

14. IL VOLTO

DURATA : 05:11

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo avvincente video, ci immergiamo nell'approccio osteopatico al viso partendo dalla comprensione embriologica e dall'importanza dell'ambiente nella nostra riorganizzazione corporea. Gli studenti impareranno a collegare gli archi mandibolari alla base del cranio, esplorando al contempo il ruolo dei sistemi ghiandolare, circolatorio e neurologico nell'equilibrio del viso. Questa formazione pone l'accento sulla dinamica tra il viso e lo sviluppo del cervello, e sull'importanza della sinfisi sfeno-basilare per favorire una guarigione profonda. I partecipanti saranno inoltre sensibilizzati ai complessi processi della cresta neurale e al loro impatto sulla nostra salute globale, integrando un approccio pratico per trattare le iper e ipomobilità legate a queste strutture.

IL VOLTO: APPROCCIO OSTEOPATICO E SVILUPPO EMBRIOLOGICO

In questo corso, esploreremo la **pratica osteopatica** del volto, adottando un approccio **olistico**. Ciò significa che non ci concentreremo solo su aree specifiche, ma prenderemo in considerazione l'ambiente che ci circonda, poiché questo ambiente gioca un ruolo cruciale nella nostra riorganizzazione.

Il **volto** è un riflesso indiretto della **cresta neurale**, un tessuto che riceve e trasmette informazioni attraverso una rete complessa nel corpo. Questa rete è presente sia nelle zone **periferiche** che **viscerali**. Così, il volto esprime l'interno e, a sua volta, informa l'interno.

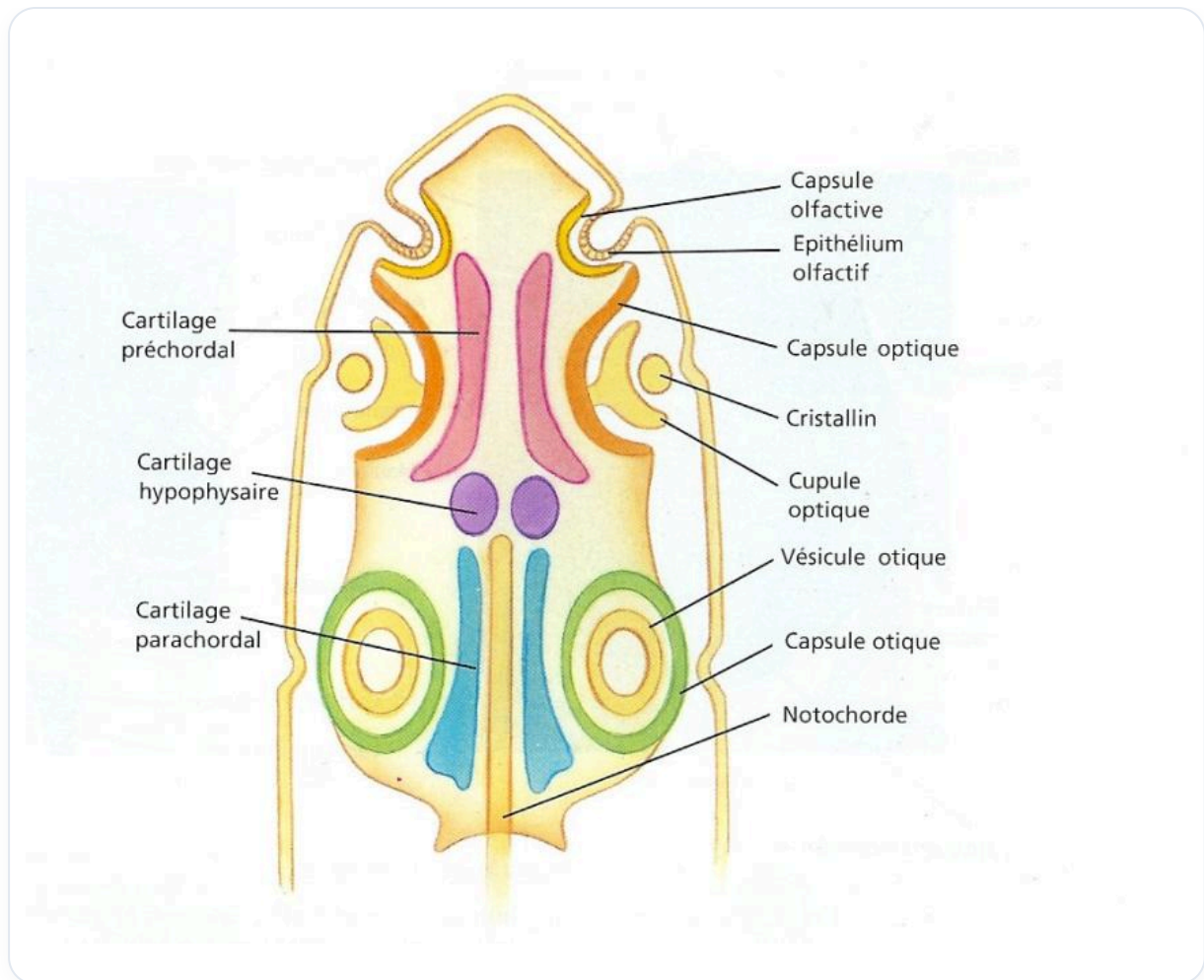


FIG. — Testa embrionale vertebrato

Durante la formazione embrionaria, gli **archi mandibolari** si sviluppano dalle tasche branchiali, creando linee di forza che si orientano verso la **base del cranio**. Questa base riceve una convergenza di informazioni facciali, influenzando il sistema **ghiandolare, circolatorio, linfatico**, e persino il sistema **neurologico**. È essenziale comprendere che questa base del cranio rappresenta un equilibrio tra il **neurocranio** e il **viscerocranio**, e che tutte le informazioni vi sono integrate.

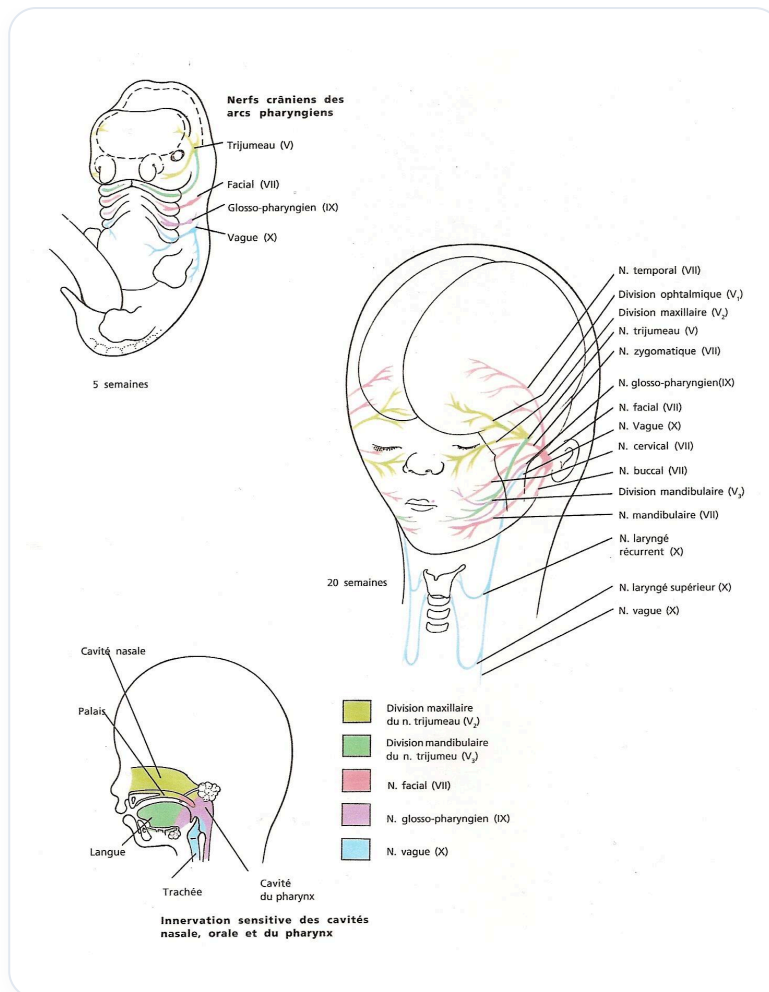


FIG. — Sviluppo innervazione cefalica

Esamineremo anche come riequilibrare la **sinfisi sfenobasilare** su un piano tensionale e osteopatico. Una tiroide disfunzionale può causare **ipomobilità**. È importante ricordare che nel processo di guarigione, si tratta sempre di **prendere** e **dare**. Le persone che soffrono di congestione sono spesso quelle che non riescono a dare.

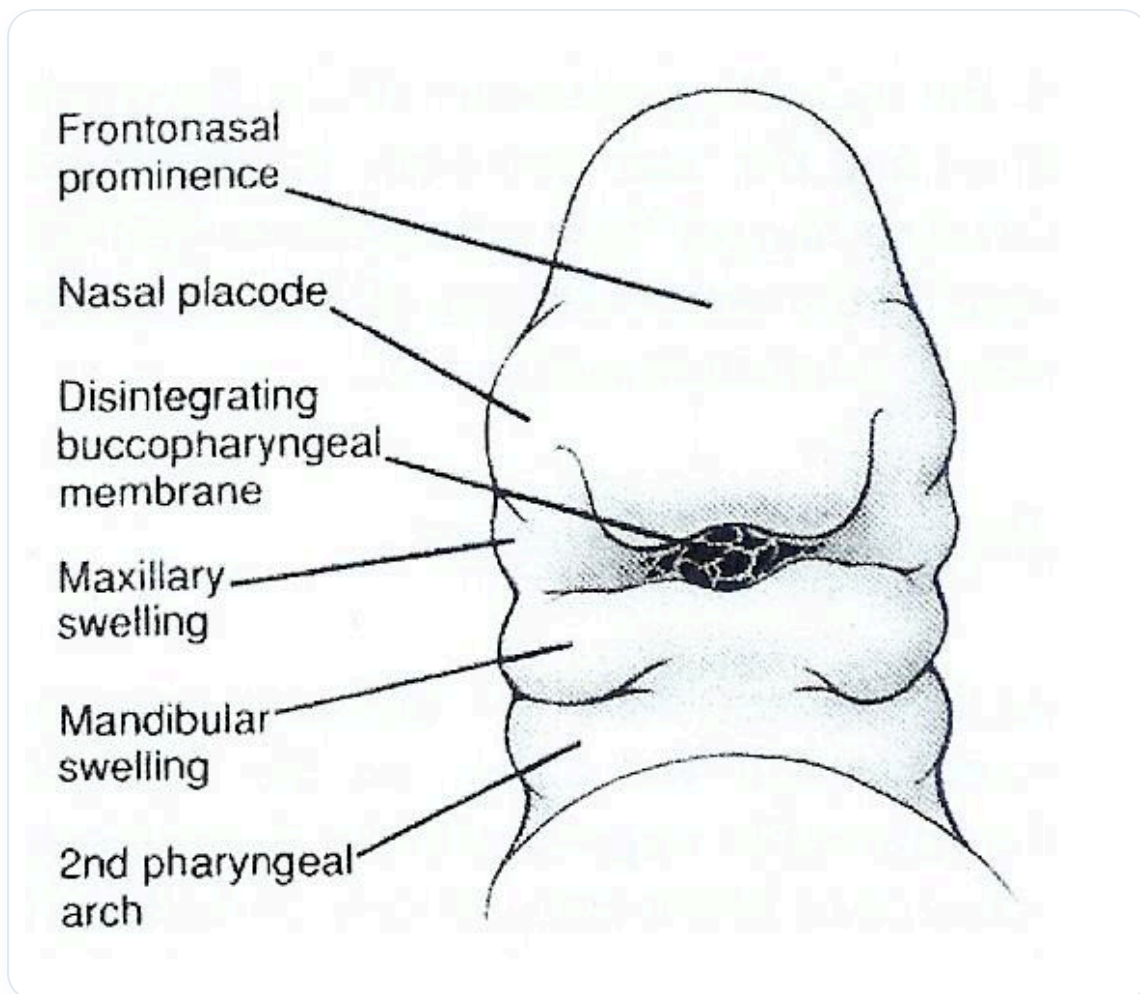


FIG. — Sviluppo facciale embrionale

La dinamica del volto è legata allo sviluppo del **cervello**. Inizialmente, il cervello è composto da un **prosencefalo** e altre strutture. Il prosencefalo si sviluppa formando due sfere laterali che si ipertrofizzano, creando un movimento dinamico. Questo movimento permette la formazione del **frontale** e degli emisferi sinistro e destro.

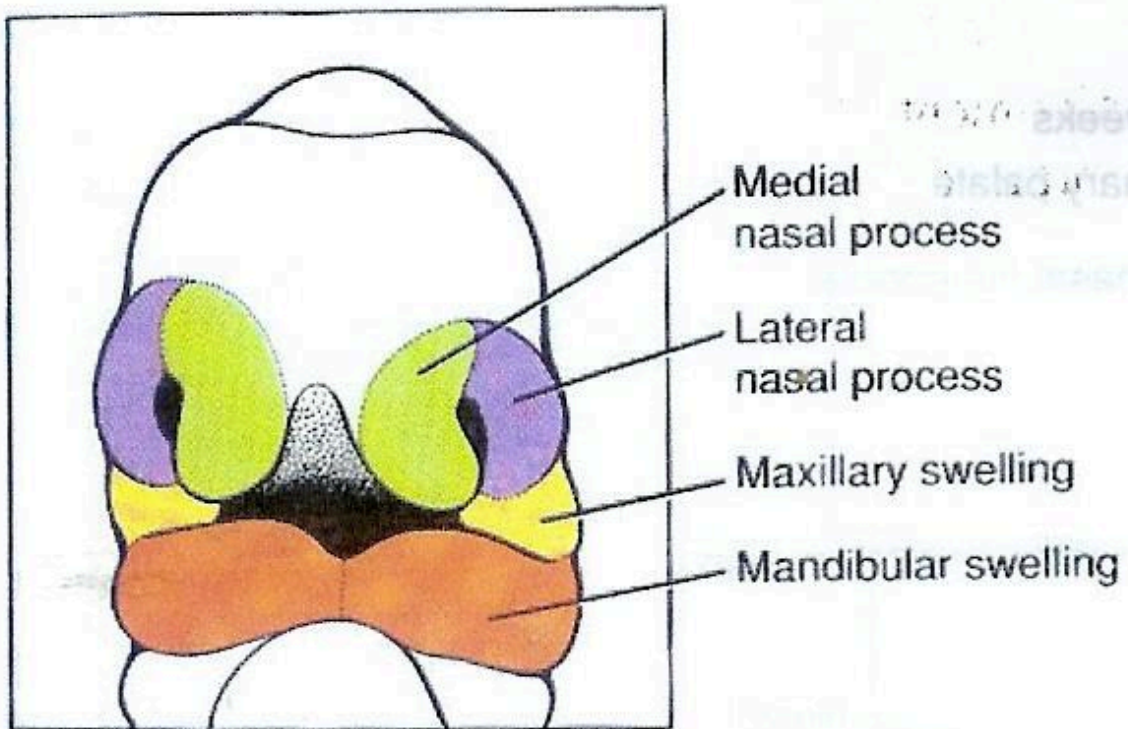


FIG. — Sviluppo facciale precoce

Man mano che questo sviluppo procede, il volto, inizialmente compresso tra il cuore e il cervello, si apre nello spazio. Le zone laterali, come la **placode ottica** e la **placode nasale**, si integrano verso la linea mediana, formando così una linea mediana di anticipazione.

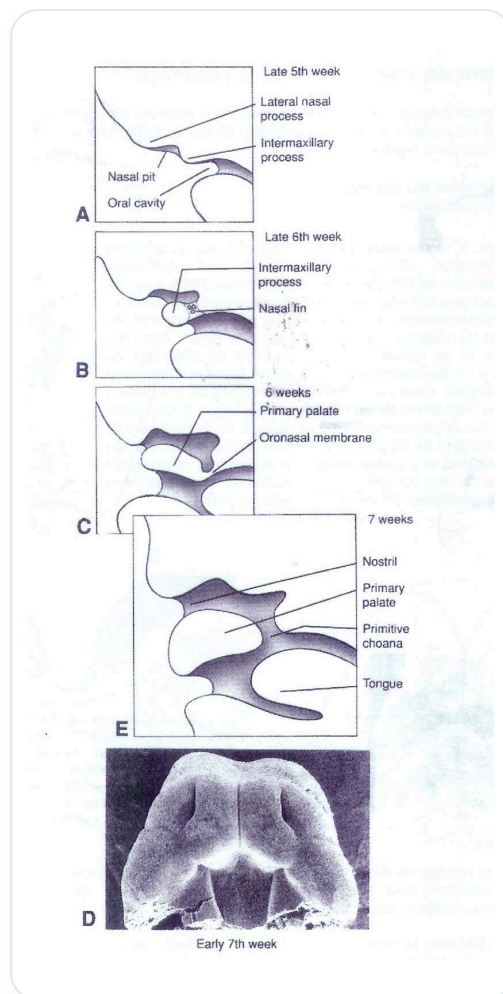


FIG. — Sviluppo palato primario

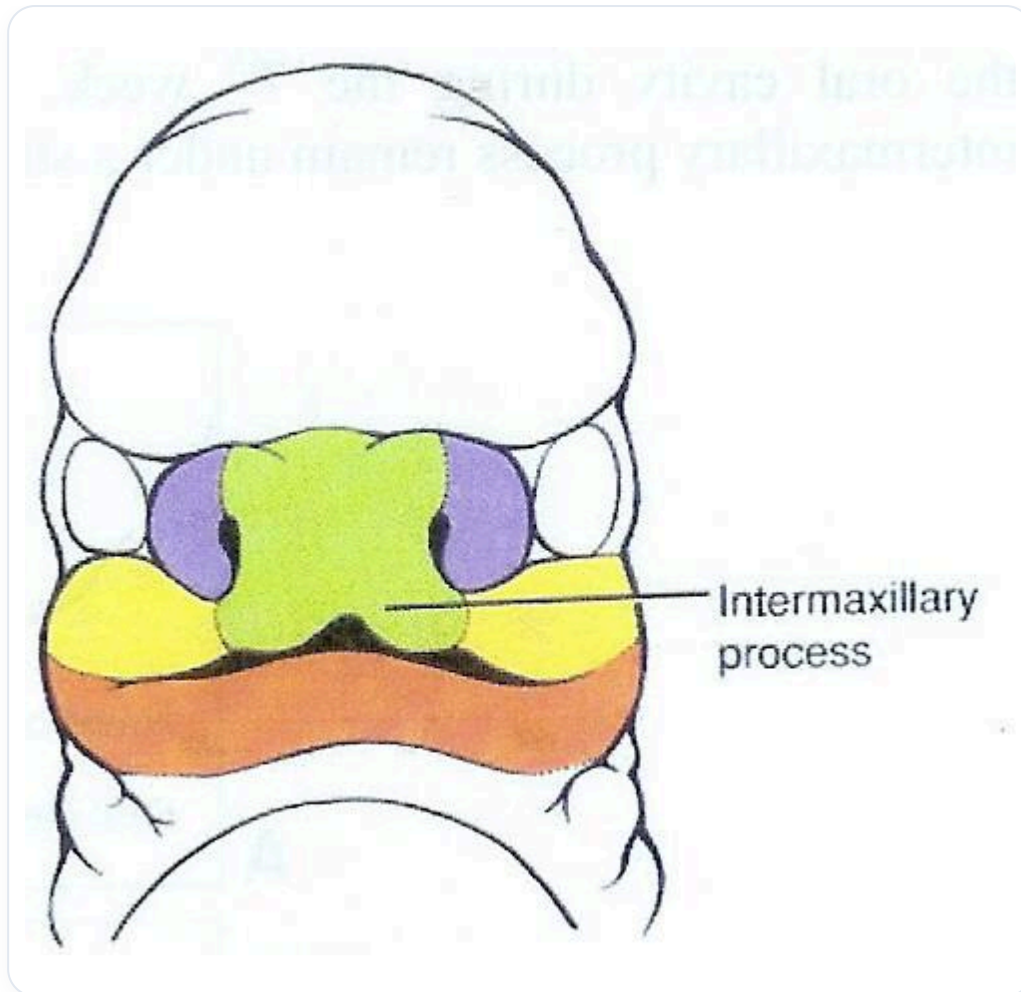


FIG. — Sviluppo facciale embrionale

Osserviamo anche la **migrazione della cresta neurale**, che si estende dal **mesencefalo** posteriore e invade il **mesoderma** per formare il **mesectoderma**. Questo processo di integrazione si verifica simultaneamente con lo sviluppo del cervello e l'organizzazione delle **guaine durali**.

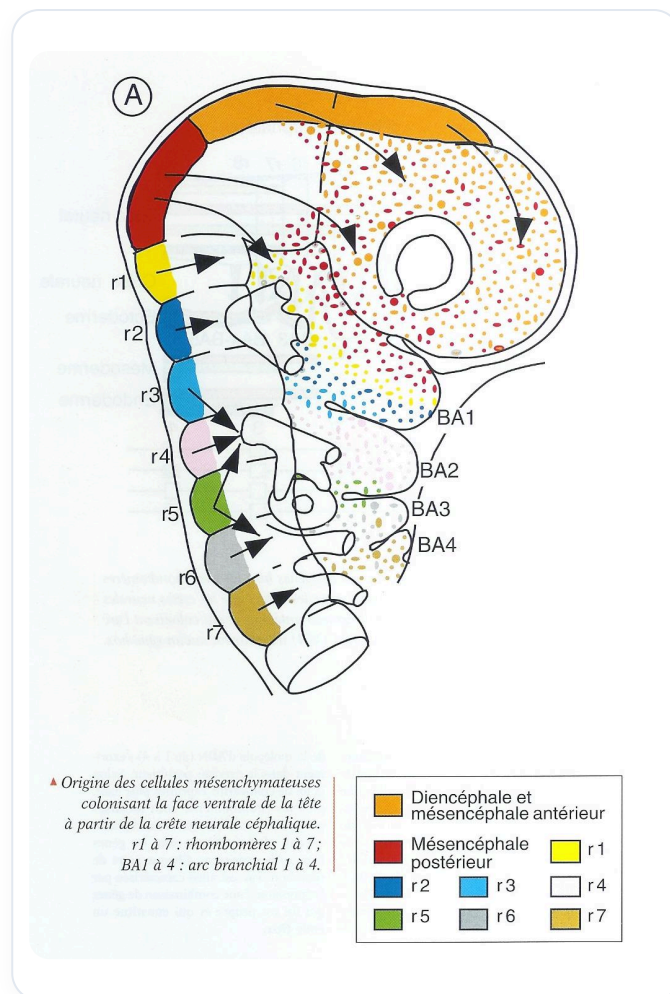


FIG. — Migrazione cresta neurale

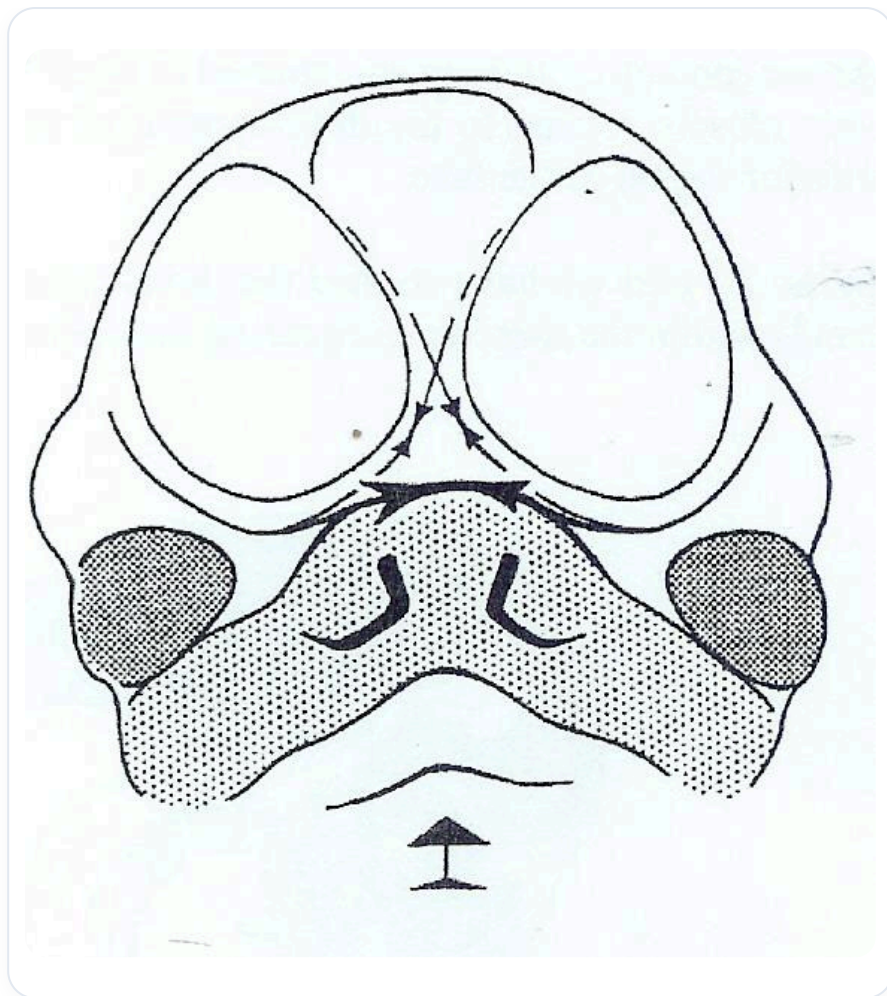


FIG. — Morfogenesi facciale sviluppo umano

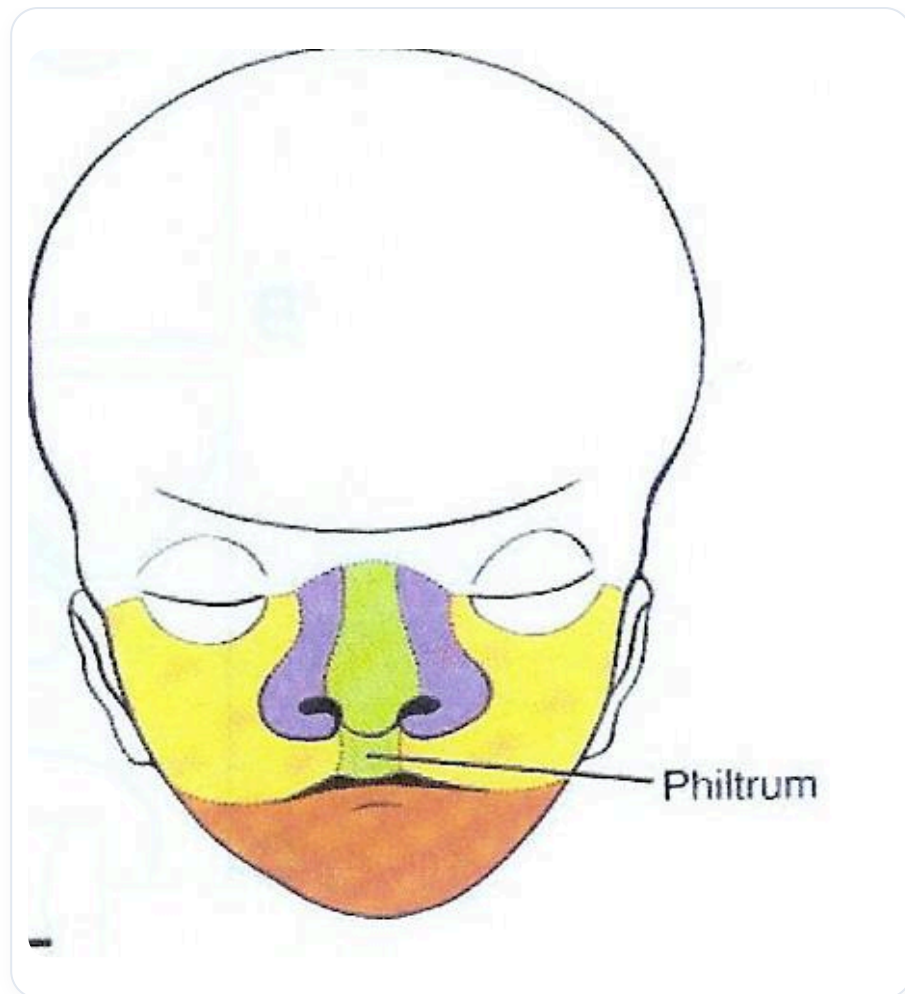
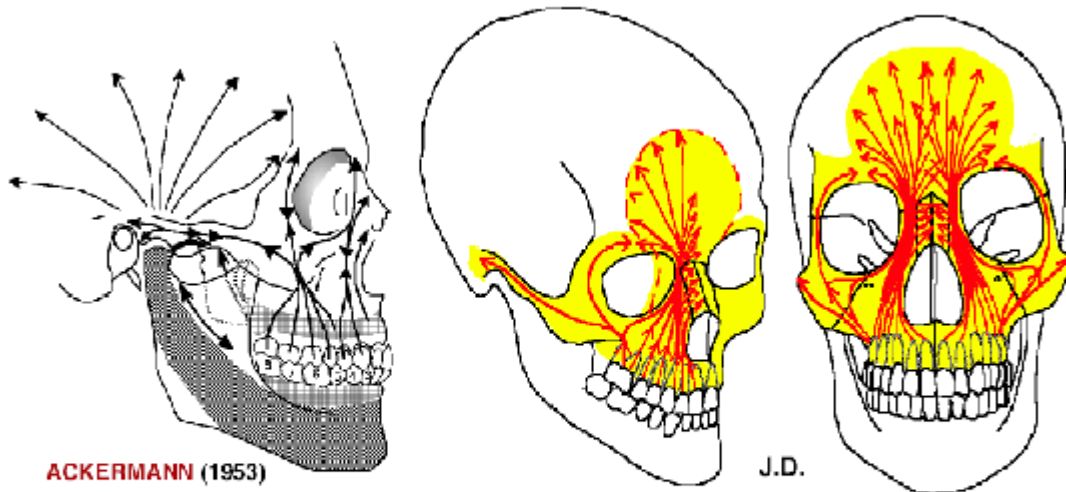


FIG. — Sviluppo facciale embrionale

Infine, è importante notare che la zona dalla superficie alla profondità, rappresentata dal mesectoderma, comprende la pelle, i muscoli, le ossa e altre strutture come la cornea. Questa integrazione è essenziale per comprendere la complessità del volto e il suo ruolo nella nostra salute generale.

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure



Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

FIG. — Forze piezoelettriche craniche